**Poder Judiciário**
**Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul**
**3ª Vara Cível da Comarca de Sapiranga**

Rua Alberto Schmidt, 441 - Bairro: Centenário - CEP: 93800312 - Fone: (51) 3098-5796 - Balcão Virtual: (51) 98064-2547 - Email: frsapirang3vciv@tjrs.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5008738-19.2023.8.21.0132/RS**

**AUTOR**: ILAIDE INEZ CAVALHEIRO

**RÉU**: UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA.

# SENTENÇA

**(i) Relatório**

Trata-se de ação declaratória negativa de débito ajuizada por ILAIDE INEZ CARVALHO contra UNIMED ENCOSTA DA SERRA. A autora alegou ser beneficiária de plano de saúde da ré e que esteve internada no período de 07/04/2023 a 29/05/2023 para tratamento, oportunidade em que lhe foram administradas 66 ampolas de OCTREOTIDE (SANDOSTATIN 0,5mg), devido à ineficácia das terapias convencionais para combater a doença a que estava acometida. Relatou que a internação foi autorizada pelo plano e que, ao utilizar o medicamento, foi informada de que estaria coberto. No entanto, em 29/08/2023, foi surpreendida com a informação de que o medicamento não seria coberto pelo plano de saúde. Disse que, desde então, tem sido cobrada pelo hospital pelo valor de R$ 33.689,90, referente ao custo do medicamento. Argumentou que está sofrendo desgaste emocional em virtude da situação e destacou que o tratamento foi necessário, conforme atestado médico emitido durante a internação. Ressaltou que o medicamento está incluído no rol de fármacos com cobertura obrigatória pela ANVISA e que a negativa de cobertura do plano ocorreu unicamente em razão do uso *off label* do medicamento. Enfatizou que o comportamento da ré é abusivo, uma vez que, naquele momento, o fármaco utilizado era o único capaz de garantir sua sobrevivência. Teceu considerações sobre os danos morais sofridos, pelo qual pretende ser indenizada. Discorreu sobre o direito que entende aplicável. Requereu a procedência da ação, para o fim de determinar que a ré arque com os custos do medicamento utilizado durante a internação, além de condenar ao pagamento de indenização por danos morais. Pediu a concessão da gratuidade da justiça e juntou documentos.

Foi concedida a gratuidade da justiça e indeferido o pedido de antecipação de tutela pleiteado (evento 8, DESPADEC1).

A ré, citada, apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, o litisconsórcio necessário com o Hospital Regina. No mérito, abordou sobre a natureza do plano de saúde existente, argumentando que tratamentos e medicações experimentais não estão cobertos pelo plano pactuado. Afirmou que não há abusividade, pois o contrato atende aos requisitos legais. Discorreu sobre o uso do medicamento *off label*, alegando que a bula do fármaco utilizado pela autora indica uma aplicação diversa da necessária para o seu quadro de saúde. Sustentou que o medicamento não possui indicação para tratar o problema de saúde da requerente e que o rol de procedimentos da ANS impõe uma limitação quanto ao custeio de tratamentos por planos de saúde. Asseverou acerca do enunciado 21 do CNJ. Mencionou sobre a alteração da legislativa promovida pela Lei 14.454/2022, que exige a comprovação de eficácia do medicamento ou sua recomendação para uso em tratamento diverso do indicado. Argumentou que não há obrigação da ré em custear o uso do medicamento e insurgiu-se contra a pretensão de indenização por danos morais. Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos (evento 16, CONT1).

A parte autora manifestou-se em relação à peça defensiva apresentada (evento 22, RÉPLICA1).

O Ministério Público, intimado, apresentou parecer declinando da intervenção (evento 25, PROMOÇÃO1).

A preliminar apresentada pela parte ré na contestação foi analisada como um pedido de denunciação da lide do Hospital Regina, tendo sido indeferida essa modalidade de intervenção de terceiro, pelos fundamentos jurídicos apresentados. Na mesma decisão, as partes foram intimadas para postularem outras provas (evento 28, DESPADEC1).

A autora reiterou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida (evento 32, PED LIMINAR_ANT TUTE1), o qual foi novamente indeferido (evento 36, DESPADEC1).

A ré juntou documentos (evento 41, PET1).

Declarada encerrada a instrução processual, a parte autora apresentou memoriais (evento 44, ALEGAÇÕES1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Esse é o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

**(ii) Fundamentação**

O feito comporta julgamento no estado que se encontra, sendo dispensável prosseguir com a instrução probatória, já que presentes os elementos de prova necessários para a apreciação do mérito da questão em julgamento, como dispõe o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação em que a parte autora, portadora de Linfoma da Zona Marginal – MALT (CID C85.9), busca a condenação da ré ao custeio do medicamento utilizado em seu tratamento durante o período de internação, além do pagamento de indenização por dano moral, em virtude dos fatos alegados.

No caso em questão, são incontroversos o vínculo contratual e a utilização do medicamento Octreotide pela autora durante o período de internação. Além disso, não está em discussão a cobertura para a patologia apresentada pela autora nem o tratamento necessário para a sua condição.

Contudo, a requerida fundamenta sua negativa na alegação de que a medicação solicitada seria "tecnicamente experimental", motivo pelo qual estaria expressamente excluída da cobertura do plano privado de assistência à saúde.

Inicialmente, destaca-se que o caso deve ser apreciado levando-se em conta o disposto no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor:

> *Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.*
>
> *§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.*
>
> *§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.*

A questão resta pacificada e cristalizada no Verbete Sumular nº 608, do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*".

No ponto, valiosa a lição de Cláudia Lima Marques, que na obra *Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais*, assim se manifestou:

> *Resumindo, em todos estes contratos de seguro podemos identificar o fornecedor exigido pelo art. 3º do CDC, e o consumidor. Note-se que o destinatário do prêmio pode ser o contratante com a empresa seguradora (estipulante) ou terceira pessoa, que participará como beneficiária do seguro. Nos dois casos, há um destinatário final do serviço prestado pela empresa seguradora. Como vimos, mesmo no caso do seguro-saúde, em que o serviço é prestado por especialistas contratados pela empresa (auxiliar na execução do serviço ou preposto), há a presença do 'consumidor' ou alguém a ele equiparado, como dispõe o art. 2º e seu parágrafo único.*

Importante também relembrar que o Superior Tribunal de Justiça entende que operadora de plano de saúde não pode determinar qual o tratamento a ser ministrado pelo profissional médico ao seu paciente, sendo abusiva qualquer cláusula que exclua terapias ou procedimentos prescritos como imprescindíveis para garantir a vida e a saúde do beneficiário do plano, seja o tratamento *off label* (fora da bula), de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental (AgRg no REsp 1.547.168/SP; AgInt no AREsp 1.573.008/SP).

No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do RS:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM ÂMBITO DOMICILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. MULTA FIXADA. DECISÃO REFORMADA. 1. OS PLANOS OU SEGUROS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ENQUANTO RELAÇÃO DE CONSUMO ATINENTE AO MERCADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ISTO É O QUE SE EXTRAI DA INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 35 DA LEI 9.656/98. SÚMULA N. 608 DO STJ. 2. A TUTELA DE URGÊNCIA SERÁ CONCEDIDA QUANDO HOUVER ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO, HOUVER PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 300 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 3. NO CASO EM EXAME RESTOU DEMONSTRADO O PERIGO DE DANO À SAÚDE DA PARTE AUTORA, TENDO EM VISTA QUE APRESENTA SEQUELAS MOTORAS IMPORTANTES DECORRENTES DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (CID 10 I63.9, I69.4 E R47.0), INDICANDO O SEU MÉDICO ASSISTENTE ATENDIMENTO HOME CARE. 4. AINDA, ESTÁ PRESENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO, POIS, EM TESE,* ***OS PLANOS DE SAÚDE SOMENTE PODEM ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS OFERECERÃO COBERTURA, NÃO LHES CABENDO LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, INCUMBÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA ÁREA MÉDICA QUE ASSISTE AO PACIENTE****. 5. É JURIDICAMENTE POSSÍVEL A FIXAÇÃO MULTA PECUNIÁRIA A FIM DE INSTAR A PARTE DEMANDADA A CUMPRIR O PROVIMENTO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA FIXADA NO EVENTO 11, MANTIDA. DADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 50760763820218217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 25-08-2021).*
>
> APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO **DECLARATÓRIA** DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS NÃO COBERTAS PELO PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DE *MEDICAMENTO* PARA TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL GRAVE. HEMAX. NEGATIVA DE COBERTURA SOB O ARGUMENTO DE QUE O *MEDICAMENTO* NÃO ERA INDICADO PARA A PATOLOGIA. DESCABIMENTO. DESPESAS A SEREM PAGAS PELO PLANO DE SAÚDE DIRETAMENTE AO HOSPITAL. EXTINÇÃO DO PEDIDO RECONVENCIONAL. INSCRIÇÃO NEGATIVA EM RAZÃO DA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. ABALO DE CRÉDITO CONFIGURADO. PLEITO INDENIZATÓRIO. **PROCEDENTE**. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de parcial procedência de ação **declaratória** de inexistência de débito cumulada com

indenização por dano moral e de procedência de reconvenção. Segundo a exordial, a genitora da parte autora, beneficiária do contrato de plano de saúde firmado com a cooperativa ré, foi internada no hospital réu, no período de 08.09.2008 a 22.10.2008, quando faleceu. Relatou que o **médico** do hospital demandado remeteu solicitação à *Unimed* para cobertura do *medicamento* Hemax, que seria utilizado para tratamento do quadro de anemia profunda e insuficiência renal aguda. Contudo, a demandada negou cobertura sob o fundamento de que o *medicamento* não seria indicado para a patologia. Aduziu que, após três anos do falecimento de sua mãe, ao tentar realizar uma compra no comércio, foi surpreendida com a negativa de crédito por seu nome estar inscrito em órgãos de proteção ao crédito por ordem do nosocômio demandado. Pugnou, em sede de antecipação de tutela, a exclusão do seu nome dos cadastros de devedores. No mérito, requereu a declaração de inexistência de débito e a obrigação da cooperativa ré quanto à dívida existente junto ao hospital demandado, condenando-a ao pagamento, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral. COBERTURA PARA *MEDICAMENTO OFF LABEL* - **As operadoras de plano de saúde podem estabelecer quais as doenças cobertas, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser prescrito ao paciente. Precedentes. A negativa da cooperativa ré não encontra qualquer amparo legal ou contratual, razão pela qual deveria ter custeado o *medicamento* eritropoetina humana - Hemax prescrito à genitora da demandante pelo profissional médico que lhe assistia, quando se encontrava internada no nosocômio réu.** PAGAMENTO DAS DESPESAS - Com a procedência da ação, pelo menos em relação ao pedido dirigido contra à cooperativa, sendo esta reconhecida na sentença como responsável pelos custos da medicação utilizada, não poderia ser outro o desfecho da reconvenção senão o da extinção por perda de objeto e ilegitimidade passiva da reconvinda . Se o entendimento adotado em relação à impossibilidade de se determinar que uma ré pague à outra pode ser admitido, embora sem qualquer efeito prático, a possibilidade de a parte autora ser condenada a pagar a medicação em favor do nosocômio depois de ser proclamado que a responsável pelo pagamento é a prestadora do plano de saúde não pode ser admitido. DANO MORAL - "In casu ", a conduta da cooperativa ré ultrapassou a esfera do mero descumprimento contratual, pois deu ensejo à inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito por dívida que não era de sua responsabilidade, pois o *medicamento* prescrito à sua genitora possuía cobertura contratual. Segundo o entendimento deste Relator, o cadastramento indevido no rol de inadimplentes, via de regra, enseja o dever de reparação de abalo de crédito, mas não por dano moral. No caso concreto, a segunda ré não impugnou a alegação da parte autora no sentido de que foi privada de exercer seu direito de crédito em razão da inscrição negativa, limitando-se a defender a inexistência de ato ilícito de sua parte. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - Na fixação do dano deve-se ponderar sobre as condições socioculturais e econômicas dos envolvidos, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico e as finalidades reparatório-retributivas da condenação , de tal forma que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que sirva de desestímulo ao ofensor, nem tampouco exacerbada a ponto de implicar enriquecimento sem causa para a parte autora. "Quantum" fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto e observado o valor arbitrado em casos análogos. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA SEGUNDA RÉ DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70062111810, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 28-04-2016) (grifei).

Quanto ao argumento da ré de que se trata de medicamento *off label*, e a tese subsidiária (necessidade de comprovação da eficácia do tratamento), tenho que não pode ser acolhida.

Primeiro porque, depreendendo-se que o medicamento está no rol da ANS, embora com prescrição para outras doenças, é do médico assistente a competência para prescrever ao seu paciente o melhor tratamento ou aquele que se mostre adequado e suficiente, em cada caso, considerando o quadro de saúde da paciente.

Com isso, negar a cobertura de tratamento previsto no rol da ANS, como no caso dos autos, sob a justificativa de que inexiste comprovação acerca da eficácia do uso do medicamento para o quadro de saúde da parte autora, representa prejuízo à segurada.

Além disso, entendo que o laudo apresentado pela demandante, devidamente firmado pelo médico assistente, é suficiente para sustentar a eficácia do tratamento utilizado:

LAUDO MÉDICO

A Sra Ilaide Inez Cavalheiro teve diagnóstico em março de 2023 de um Linfoma da zona marginal - MALT CID C85.9 (diagnóstico por biópsia de pleura). Iniciou tratamento com quimioterapia, esquma R-CHOP, em 07/04/23. Evoluiu com derrame pleural volumoso, com importante limitação da expansão pulmonar e insuficiência respiratória, sendo realizadas múltiplas toracocenteses.

- 19/04/23 – toracocentese, 2500 ml

26/04/23 – toracocentese, 3800 ml,

02/05/23 - toracocentese 3700 ml,

03/05/23 - drenagem tórax,

12/05/23 - toracocentese 2000 ml,

21/05/23 - drenagem torácica que evidenciou quilotórax.

Apesar da restrição de gordura na dieta e drenagem do tórax, não reduzia o volume de drenagem de linfa, sendo então administrado octreotide para reduzir o débito. Evoluiu de forma favorável, tendo alta em 29/05/23. Octreotide foi indicado devido à ineficiência das medidas tradicionais e por não haver disponível outra terapia coadjuvante com eficiência comprovada nesta situação.

Atenciosamente,

Dr. André F. Marinato
Hematologia
CRM 48.203

André Marinato

Desta forma, em se tratando de negativa de cobertura abusiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, afigura-se indevida a recusa da operadora.

A respeito do assunto, trago julgado do Tribunal de Justiça do RS:

*APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ATEZOLIZUMABE E BEVACIZUMABE). NEGATIVA DE COBERTURA SOB O PRETEXTO DE SE TRATAR DE MEDICAÇÃO EXPERIMENTAL - OFF-LABEL. COBERTURA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. POR DECISÃO MONOCRÁTICA, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível, Nº 50221255020218210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 13-01-2025).*

*DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RITUXIMABE (MABTHERA) PARA TRATAMENTO DE GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA GRAVE. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - CASO EM EXAME Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido em ação em que o autor busca o fornecimento do medicamento Rituximabe (Mabthera) em conformidade com a indicação médica, para o tratamento da doença de glomerulonefrite membranosa grave. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO Requerida que objetiva afastar o fornecimento do fármaco, sob a alegação de que o tratamento é "off-label" ou de uso experimental e não consta no rol taxativo da ANS, bem como afastar a indenização por dano moral. III - RAZÕES DE DECIDIR Viabilidade de cobertura do fármaco mabthera, que se trata de fármaco antineoplásico ministrado para ambiente domiciliar, considerando a disposição do artigo 12, "c", da Lei nº 9.656/98. Consoante jurisprudência do STJ e desta Corte, mostra-se abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental. Configurado o abalo moral decorrente da negativa da ré no fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de doença renal grave. Mantida a condenação da ré ao pagamento de indenização. Valor fixado na sentença adequado e suficiente para reparar o prejuízo experimentado, além de cumprir a finalidade pedagógica, mostrando-se incabível qualquer redução. IV - DISPOSITIVO 7. Apelação não provida. Dispositivo legal relevante citado: Artigo 12, "c", da Lei nº 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.005.551/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022; TJ/RS, Agravo de Instrumento, Nº 50909563020248217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 26-06-2024 e Agravo de Instrumento, Nº 52086291520228217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-04-2023.(Apelação Cível, Nº 50031817420228210071, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em: 18-12-2024).*

Assim, merece acolhimento o pedido da parte autora, no que tange à condenação da ré ao pagamento do valor dos medicamentos utilizados pela autora durante a sua internação, no montante de R$ 33.689,90, com as correções respectivas em razão da mora.

Em relação aos danos morais, analisando as peculiaridades do caso, a negativa do plano de saúde configura-se como ato ilícito a ensejar reparação.

Com tal indenização, busca-se a reparação satisfativa àqueles que sofreram o abalo moral, levando-se em conta a dor e o sofrimento psicológico suportados.

Para Humberto Theodoro Júnior (1. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, pp. 2 e 8.), os danos morais são aqueles:

> *(...) ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana ("o da intimidade e da consideração pessoal"), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua.*
>
> *(...) quanto à prova, a lesão ou dor moral é fenômeno que se passa no psiquismo da pessoa e, como tal, não pode ser concretamente pesquisado. Daí porque não se exige do autor da pretensão indenizatória que prove o dano extrapatrimonial. Cabe-lhe apenas comprovar a ocorrência do fato lesivo, de cujo contexto o juiz extrairá a idoneidade, ou não, para gerar dano grave e relevante, segundo a sensibilidade do homem médio e a experiência da vida.*

Assim, no que tange à indenização por danos morais, não há dúvidas quanto à sua aplicabilidade ao caso dos autos, em razão da ofensa comprovadamente perpetrada à integridade física da paciente. Isso porque não se trata de simples descumprimento contratual, mas sim de um reflexo na esfera íntima da requerente, ofendendo sua honra, causando-lhe sofrimento e angústia que ultrapassam o mero dissabor, diante da negativa abusiva em custear o tratamento da autora, bem como pelo fato de a autora estar sofrendo cobranças do hospital onde foi internada.

No entanto, na fixação do *quantum*, não se pode permitir o enriquecimento indevido, com a fixação de montantes excessivos, assim como não pode haver valor ínfimo que sequer compense o dano experimentado pela vítima, pois o ressarcimento deve servir para evitar a repetição da conduta danosa.

Portanto, deve-se analisar o caso concreto, considerando as condições econômicas das partes, a repercussão do dano e o grau de culpa quando do evento danoso, sem deixar de lado os parâmetros adotados pela doutrina e jurisprudência para que o dano seja devidamente ressarcido, razão pela qual o fixo no montante de R$ 5.000,00, a ser acrescido da Taxa SELIC, desde a citação da demandada.

Nesse sentido, colacionado recente julgado da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo:

> *AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO.USO OFF LABEL. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label ou de caráter experimental. 3. Havendo a indevida recusa ao fornecimento de tratamento pela operadora de saúde e reconhecendo a corte de origem ser inegável a dor e o sofrimento experimentados pelo beneficiário de plano, é cabível a condenação a indenização por danos morais. 4. Agravo interno desprovido. (AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2022/0360346-9, T4 - QUARTA TURMA, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Julgado em: 08/04/2024). - grifei*

Dessa forma, a procedência da ação é medida que se impõe.

**(iii) Dispositivo**

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos de ILAIDE INEZ CAVALHEIRO em face de UNIMED ENCOSTA DA SERRA, para fins de:

(i) Condenar a ré ao custeio das 66 ampolas de OCTREOTIDE (SANDOSTATIN 0,5mg) ministradas na autora durante sua internação, no período de 07/04/2023 a 29/05/2023, no valor de R$ 33.689,90, acrescido dos correspondentes encargos de mora exigidos.

(ii) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00, que deverá ser atualizado pelo IPCA desde a presente data e acrescido de juros de mora pela variação da SELIC, deduzida a variação do IPCA, desde a data da citação, na forma do art. 406, §1°, do Código Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como os honorários advocatícios do procurador da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, levando em conta o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85, §2º).

Os honorários advocatícios serão atualizados conforme a variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) desde a data desta sentença, acrescidos de juros de mora de 12% ao ano a partir da data do trânsito em julgado.

Interposto eventual recurso, proceda-se à intimação da parte adversa para apresentação de contrarrazões e, após, à remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, nos moldes do disposto no art. 1.010, §§ 1º a 3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos à CCalc, para cálculo das custas finais em face da parte vencida, intimando-a para pagamento.

Em nada mais sendo requerido, arquivem-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO MICHELIN PINTO, Juiz de Direito**, em 28/02/2025, às 15:28:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10077808889v14** e o código CRC **9b201fe4**.